PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA: HIPERTENSÃO, DIABETES, DOENÇAS CARDIOVASCULARES, OBESIDADE, DOENÇA RENAL CRÔNICA, HANSENÍASE, TUBERCULOSE, DENGUE E IST

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 9 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

9.1 Hipertensão arterial sistêmica (HAS)

Diagnóstico: PA **≥ 140/90 mmHg** em pelo menos duas ocasiões (Diretriz Brasileira de Hipertensão). É, em geral, **assintomática** ("assassina silenciosa"). Fatores de risco: idade, hereditariedade, excesso de sal, obesidade, sedentarismo, tabagismo, álcool, estresse. Complicações (lesão de órgão-alvo): AVC, infarto, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, retinopatia.

Classificação (consultório)	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
PA ótima	< 120	< 80
PA normal	120–129	80–84
Pré-hipertensão	130–139	85–89
HAS estágio 1	140–159	90–99
HAS estágio 2	160–179	100–109
HAS estágio 3	≥ 180	≥ 110

Tratamento não medicamentoso: redução do sal (**< 5 g de sal/dia**, equivalente a 2 g de sódio), dieta DASH (rica em frutas, verduras, laticínios magros), atividade física (150 min/semana), perda de peso, cessação do tabagismo e moderação do álcool. Medicamentos comuns na atenção básica: hidroclorotiazida (diurético – pode causar hipopotassemia), captopril/enalapril (IECA – **tosse seca**), losartana (BRA), anlodipino (bloqueador de canal de cálcio – edema de tornozelos), propranolol/atenolol (betabloqueadores – bradicardia, contraindicados na asma).

9.2 Diabetes mellitus (DM)

Critério diagnóstico	Valor
Glicemia de jejum (8 h)	≥ 126 mg/dL
Glicemia 2 h após sobrecarga de 75 g de glicose (TOTG)	≥ 200 mg/dL
Hemoglobina glicada (HbA1c)	≥ 6,5%
Glicemia ao acaso com sintomas clássicos	≥ 200 mg/dL

Pré-diabetes: glicemia de jejum de 100 a 125 mg/dL ou HbA1c de 5,7% a 6,4%. **DM tipo 1**: destruição autoimune das células beta, início geralmente na infância/adolescência, dependente de insulina, risco de **cetoacidose**. **DM tipo 2**: resistência à insulina, associado a obesidade e idade, mais frequente (cerca de 90% dos casos). **Diabetes gestacional**: diagnosticado na gestação.

Sintomas clássicos: os **4 Ps** – poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso.

Insulinas: regular (ação rápida – aspecto **transparente**, pode ser EV) e NPH (ação intermediária – aspecto **leitoso/turvo**). Na mistura na mesma seringa, aspira-se **primeiro a regular (transparente) e depois a NPH (turva)**. A NPH deve ser homogeneizada rolando-se o frasco entre as mãos, sem agitar. Aplicação subcutânea com **rodízio** dos locais (abdome – absorção mais rápida –, braços, coxas, nádegas) para prevenir lipodistrofia. Frasco em uso pode ficar em temperatura ambiente (até 30 °C) por cerca de 4 semanas; frascos lacrados são guardados na geladeira (2 °C a 8 °C), nunca no congelador nem na porta.

Pé diabético: examinar os pés diariamente, secar bem entre os dedos, hidratar (exceto entre os dedos), cortar as unhas retas, usar calçados fechados e confortáveis, nunca andar descalço, avaliar a sensibilidade com o **monofilamento de 10 g**.

Hipoglicemia (< 70 mg/dL): tremor, sudorese fria, palpitação, confusão – **regra dos 15**: 15 g de carboidrato de absorção rápida e nova glicemia em 15 minutos.

9.3 Doenças cardiovasculares, obesidade e doença renal crônica

Doenças cardiovasculares (infarto, AVC, insuficiência cardíaca) são a principal causa de morte no Brasil. A prevenção atua nos fatores de risco modificáveis: HAS, DM, dislipidemia, tabagismo, obesidade e sedentarismo.

Obesidade: IMC = peso (kg) ÷ altura² (m). Classificação do adulto: < 18,5 baixo peso; 18,5–24,9 eutrofia; 25–29,9 sobrepeso; 30–34,9 obesidade grau I; 35–39,9 grau II; ≥ 40 grau III. Circunferência abdominal aumentada (risco cardiovascular): > 94 cm em homens e > 80 cm em mulheres (risco muito elevado > 102 e > 88 cm).

Doença renal crônica (DRC): lesão renal ou taxa de filtração glomerular < 60 mL/min/1,73 m² por **mais de 3 meses**. Principais causas: **HAS e DM**. Tratamento substitutivo: hemodiálise, diálise peritoneal e transplante. Cuidados com a **fístula arteriovenosa**: não verificar PA, não puncionar, não coletar sangue nem apertar o braço da fístula; palpar o frêmito diariamente. Restrições: líquidos, sódio, potássio e fósforo, conforme orientação.

9.4 Hanseníase

Causada pelo *Mycobacterium leprae* (bacilo de Hansen), transmitida por **vias aéreas superiores** de pessoa com forma multibacilar não tratada, por contato próximo e prolongado. Período de incubação longo (2 a 7 anos). Caso de hanseníase: lesão de pele com **alteração de sensibilidade** (térmica, dolorosa ou tátil), espessamento de nervo periférico com alteração sensitiva/motora, ou baciloscopia positiva.

Classificação operacional	Critério	Tratamento (PQT-U)
Paucibacilar (PB)	Até 5 lesões de pele	Rifampicina + dapsona + clofazimina por **6 meses** (6 doses)
Multibacilar (MB)	Mais de 5 lesões ou baciloscopia positiva	Rifampicina + dapsona + clofazimina por **12 meses** (12 doses)

Dose mensal supervisionada na unidade. Orientar que a urina pode ficar avermelhada (rifampicina) e a pele escurecida (clofazimina). O paciente **deixa de transmitir logo após o início do tratamento** – não há necessidade de isolamento. Contatos: exame dermatoneurológico e BCG conforme a situação vacinal. Avaliação do **grau de incapacidade física** no diagnóstico e na alta.

9.5 Tuberculose (TB)

Causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* (bacilo de Koch), transmitida por **aerossóis** (tosse, fala, espirro) de paciente com TB pulmonar bacilífera. **Sintomático respiratório:** tosse por **3 semanas ou mais** (na população geral) – deve ser investigado com baciloscopia (2 amostras de escarro, a 1ª no momento da consulta e a 2ª na manhã seguinte, ao despertar, em jejum) ou teste rápido molecular (TRM-TB). Em populações vulneráveis (pessoas privadas de liberdade, em situação de rua, com HIV, indígenas), investiga-se a tosse de qualquer duração.

Tratamento básico (adulto, 6 meses): fase intensiva de **2 meses com RHZE** (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol) e fase de manutenção de **4 meses com RH**. Tomada diária, preferencialmente em jejum, com **Tratamento Diretamente Observado (TDO)**. Paciente bacilífero internado: **precaução por aerossóis**, quarto privativo com pressão negativa, uso de **máscara N95/PFF2** pelos profissionais e máscara cirúrgica pelo paciente durante o transporte. A transmissão reduz-se muito após cerca de 15 dias de tratamento eficaz.

9.6 Dengue

Arbovirose transmitida pela fêmea do mosquito *__Aedes aegypti__, *com 4 sorotipos (DENV-1 a 4). Fases: febril (febre alta de início súbito, cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, exantema), crítica (entre*

o 3º e o 7º dia, com a queda da febre – período de maior risco de extravasamento plasmático e choque) e de recuperação

Sinais de alarme: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos (ascite, derrame), hipotensão postural/lipotimia, hepatomegalia > 2 cm, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade, aumento progressivo do hematócrito.

Classificação e manejo: grupo A (sem sinais de alarme, sem comorbidades – hidratação oral em casa), B (sangramento de pele espontâneo ou prova do laço positiva, ou condição especial/comorbidade – exames e observação), C (sinais de alarme – hidratação venosa em leito de internação) e D (choque – reposição venosa rápida e UTI). Hidratação oral no adulto: **60 mL/kg/dia**, sendo 1/3 com soro de reidratação oral. **Não usar AAS nem anti-inflamatórios** (risco de sangramento); o antitérmico é dipirona ou paracetamol. A **prova do laço** é obrigatória na suspeita sem sangramento espontâneo: insuflar o manguito na PA média por **5 minutos** no adulto (3 min na criança) e considerar positiva com **20 ou mais petéquias** em quadrado de 2,5 cm de lado no adulto (10 ou mais na criança). Notificação compulsória; óbito por dengue é de notificação imediata. Vacina **Qdenga** no SUS para faixas etárias priorizadas (10 a 14 anos) e vacina do Butantan aprovada em 2025.

■ 9.7 Infecções sexualmente transmissíveis (IST)

- **Sífilis** (*Treponema pallidum*): primária (cancro duro, indolor), secundária (lesões de pele, inclusive palmas e plantas), latente e terciária. Diagnóstico por teste treponêmico (teste rápido) e não treponêmico (VDRL). Tratamento: **penicilina G benzatina** IM (2,4 milhões UI dose única na primária, secundária e latente recente; 3 doses semanais na latente tardia/indeterminada). A penicilina é o único tratamento eficaz na gestante para prevenir a sífilis congênita; parcerias devem ser tratadas.
- **HIV:** diagnóstico por testes rápidos; tratamento antirretroviral para todos; **PEP** (profilaxia pós-exposição) iniciada idealmente em até 2 h e no máximo em **72 horas**, por 28 dias; **PrEP** (pré-exposição) para populações com maior risco.
- **Gonorreia e clamídia:** corrimento uretral/cervical; tratamento sindrômico (ceftriaxona + azitromicina).
- **HPV:** verrugas anogenitais (condiloma) e relação com câncer de colo de útero; prevenção pela vacina.
- **Herpes genital:** vesículas dolorosas e recorrentes; aciclovir.
- **Hepatites B e C:** transmissão sexual, sanguínea e vertical; vacina disponível para a hepatite B.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- HAS ≥ 140/90 mmHg; sal < 5 g/dia; efeitos dos anti-hipertensivos (tosse do IECA).
- Critérios do DM (jejum ≥ 126; HbA1c ≥ 6,5%); 4 Ps; tipos de DM.
- Insulina: regular transparente aspirada antes da NPH; rodízio; conservação.
- Cuidados com o pé diabético e a fístula arteriovenosa.
- IMC e classificação.
- Hanseníase: PB até 5 lesões (6 doses) × MB mais de 5 lesões (12 doses).
- TB: tosse ≥ 3 semanas; RHZE 2 meses + RH 4 meses; N95.
- Dengue: fase crítica com a queda da febre; sinais de alarme; não usar AAS; prova do laço.
- Sífilis: penicilina benzatina; PEP em até 72 h.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Do claro para o turvo"**: insulina regular antes da NPH na mesma seringa.
- **"4 Ps do diabetes"**: poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso.
- **"Regra dos 15"**: 15 g de açúcar e nova glicemia em 15 minutos.
- **"Hanseníase: até 5 é pouco (6 meses), mais de 5 é muito (12 meses)"**.
- **"2 RHZE + 4 RH"**: esquema básico da TB.
- **"Febre caiu, cuidado redobrou"**: fase crítica da dengue.
- **"Braço da fístula é sagrado"**: nada de PA, punção ou garrote.
- **"PEP: 72 h, 28 dias"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Ao preparar insulina regular e insulina NPH na mesma seringa, a técnica correta é:

(A) aspirar primeiro a NPH e depois a regular.
(B) agitar vigorosamente o frasco de NPH antes de aspirar.
(C) aspirar primeiro a insulina regular (transparente) e depois a NPH (turva), após homogeneizar a NPH rolando o frasco.
(D) misturar as duas em um frasco separado antes da aspiração.
(E) aplicar por via intramuscular para acelerar a absorção.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – aspirar a NPH primeiro pode contaminar o frasco de regular com insulina de ação intermediária.

B) Incorreta – agitar forma bolhas e altera a dose; o correto é rolar o frasco entre as mãos.

C) Correta – aspira-se do claro para o turvo, protegendo o frasco de regular.

D) Incorreta – não se misturam insulinas em frascos.

E) Incorreta – a via de aplicação domiciliar é a subcutânea.

QUESTÃO 02

Paciente com hanseníase apresenta 8 lesões de pele com alteração de sensibilidade. Pela classificação operacional, trata-se de caso:

(A) paucibacilar, com tratamento de 6 doses.
(B) multibacilar, com tratamento de 12 doses mensais supervisionadas.
(C) paucibacilar, com tratamento de 12 doses.
(D) multibacilar, com tratamento de 6 doses.
(E) que exige isolamento do paciente durante todo o tratamento.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – mais de 5 lesões caracteriza forma multibacilar.

B) Correta – multibacilar (mais de 5 lesões), tratado com PQT-U por 12 meses.

C) Incorreta – a classificação está errada.

D) Incorreta – o número de doses está errado.

E) Incorreta – o paciente deixa de transmitir logo após o início do tratamento; não há isolamento.

QUESTÃO 03

Sobre o tratamento da tuberculose pulmonar no adulto, é correto afirmar:

(A) dura 2 meses, com rifampicina isolada.
(B) consiste em 2 meses de RHZE seguidos de 4 meses de RH, preferencialmente com tratamento diretamente observado.
(C) é feito por 12 meses com estreptomicina injetável.
(D) pode ser interrompido quando a tosse desaparece.
(E) dispensa precauções respiratórias no início do tratamento.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a monoterapia induz resistência; o tratamento dura no mínimo 6 meses.

B) Correta – é o esquema básico (2RHZE/4RH), com TDO.

C) Incorreta – não é o esquema básico atual.

D) Incorreta – a interrupção precoce causa recidiva e resistência.

E) Incorreta – o paciente bacilífero exige precaução por aerossóis.

QUESTÃO 04

Paciente com dengue, no 4º dia de doença, refere que a febre cessou, mas apresenta dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes. O técnico em enfermagem deve reconhecer que:

(A) a queda da febre indica cura e o paciente pode ter alta.
(B) trata-se de sinais de alarme, indicando classificação no grupo C e necessidade de hidratação venosa e comunicação imediata.
(C) deve ser administrado ácido acetilsalicílico para a dor.
(D) o paciente deve ser classificado no grupo A.
(E) os vômitos são esperados e não exigem conduta.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a defervescência marca o início da fase crítica.

B) Correta – dor abdominal intensa e vômitos persistentes são sinais de alarme (grupo C).

C) Incorreta – AAS é contraindicado na dengue pelo risco de sangramento.

D) Incorreta – o grupo A não tem sinais de alarme.

E) Incorreta – vômitos persistentes são sinal de alarme.

QUESTÃO 05

Paciente com doença renal crônica em hemodiálise possui fístula arteriovenosa no braço esquerdo. Constitui cuidado correto:

(A) verificar a pressão arterial preferencialmente no braço da fístula.
(B) coletar sangue para exames no braço da fístula para evitar novas punções.
(C) não aferir PA, não puncionar nem garrotear o braço da fístula, e verificar diariamente a presença de frêmito.
(D) manter o braço da fístula imobilizado e enfaixado.
(E) aplicar compressas frias diariamente sobre a fístula.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a compressão do manguito pode causar trombose da fístula.

B) Incorreta – punções fora da diálise aumentam o risco de infecção e trombose.

C) Correta – são os cuidados essenciais de preservação da fístula; o frêmito indica que está funcionando.

D) Incorreta – a fístula não deve ser enfaixada nem imobilizada; exercícios com bolinha favorecem sua maturação.

E) Incorreta – não há indicação de compressas frias.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: HAS (classificação, tratamento); DM (diagnóstico, tipos, insulina, pé diabético, hipoglicemia); doenças cardiovasculares; obesidade (IMC); DRC e fístula; hanseníase (PB × MB); TB (sintomático respiratório, RHZE, precauções); dengue (fases, sinais de alarme, grupos, prova do laço); IST (sífilis, HIV, PEP).

Quadro-resumo: HAS ≥ 140/90; DM jejum ≥ 126, HbA1c ≥ 6,5%; IMC ≥ 30 obesidade; hanseníase PB 6 doses e MB 12 doses; TB 2RHZE/4RH; dengue: hidratação oral 60 mL/kg/dia; prova do laço ≥ 20 petéquias (adulto).

Pegadinhas: aspirar NPH primeiro; isolar paciente com hanseníase; AAS na dengue; PA no braço da fístula.

Erros comuns: achar que a queda da febre na dengue significa melhora; confundir paucibacilar e multibacilar; interromper o tratamento da TB ao melhorar.